NGUYÊN TẮC DINH DỠNG ĐIỀU TRỊ VÀ TỔ CHỨC DINH DỠNG Ở BỆNH VIỆN

Pgs.Ts: Trần Thị Phúc Nguyệt

Đại Học Y Hà Nội

MỤC TIÊU

Sau khi học xong : học viên có khả năng

- Nêu được tầm quan trọng của ăn uống khi bị bệnh
- Thuộc các nguyên tắc xây dựng chế độ ăn cơ bản
- Tổ chức nuôl dỡng bệnh nhân trong bệnh viện

Hypocrat (460-377 TCN)

< Thức ăn cho ngời bệnh phải là phơng tiện điều trị và các phơng tiện điều trị của chúng ta phải là các chất dinh dỡng >

Sidengai ngời kế thừa di chúc của Hypocrat:

<Để nhằm mục đích phòng bệnh cũng nh điều trị trong nhiều bệnh chỉ cần cho ăn những chế độ ăn thích hợp và sống một đời sống có tổ chức hợp lý>

Hải Thợng Lãn Ông (TK 18)

<Có thuốc mà không có ăn uống thì cũng đi đến chỗ chết>

Vai trò của dinh dỡng điều trị:

1. Ăn điều trị có tác dụng trực tiếp tới nguyên nhân gây bệnh
2. Ăn điều trị làm tăng sức đề kháng chung của cơ thể
3. Ăn điều trị ảnh hởng đến cơ chế điều hoà thần kinh thể dịch
4. Ăn điều trị có vai trò trong phục hồi cơ thể
5. Ăn điều trị có tác dụng phòng bệnh
6. Ăn điều trị có vai trò trong một số bệnh chuyển hoá

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Dinh dỡng hỗ trợ dùng để chỉ cách nuôi dỡng bệnh nhân qua đờng miệng, ống thông và đờng tĩnh mạch nhằm cung cấp đầy đủ năng lợng và các chất dinh dỡng cần thiết cho ngời bệnh có nguy cơ cao.

Nuôi dỡng qua đờng miệng là cách đa thức ăn thông thờng qua đờng miệng để đáp ứng các nhu cầu dinh dỡng khác nhau cho bệnh nhân.

Nuôi dỡng qua ống thông là cách nuôi dỡng bổ sung hoặc thay thế nuôi ăn qua đờng miệng khi l-ợng thức ăn ăn vào của bệnh nhân quá thấp.

Nuôi dỡng qua đờng tĩnh mạch là sự cung cấp các chất dinh dỡng theo nhu cầu cơ thể cho bệnh nhân nặng bằng đờng tĩnh mạch. Có thể nuôi qua đờng tĩnh mạch bổ sung hoặc thay thế hoàn toàn

CÁC NGUYÊN TẮC DINH DỠNG ĐIỀU TRỊ

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DỠNG CỦA NGỜI BỆNH

1.1. Tìm hiểu tiền sử dinh dỡng

1.2. Phát hiện các triệu chứng thiếu dinh dỡng đặc hiệu

1.3. Đánh giá TTDD bằng các chỉ tiêu nhân trắc

- Ngời lớn:

$$\text{BMI (chỉ số khối cơ thể)} = \frac{\text{Cân nặng (Kg)}}{\text{Chiều cao}^2\text{(m)}}$$

- Đối với trẻ em

- SDD thể thiếu cân : CN / tuổi < - 2 SD
- SDD thể thấp còi (SDD kéo dài): CC/tuổi< - 2 SD
- SDD thể gầy còm (SDD cấp tính): CN/CC< - 2 SD
- Thừa cân CN / CC > + 2 SD

Trong lâm sàng chỉ số CN/CC là quan trọng hơn cả vì ảnh h-ởng trực tiếp đến diễn biến của bệnh

1.4. Đánh giá tình trạng dự trữ năng lợng của cơ thể

- Dự trữ Lipit: Đo Bề dày nếp gấp da. Nếu số đo đợc ở dới mức 60 % đợc coi là giảm dự trữ Lipit

- Dự trữ protein nội tạng:

  Đợc coi là thiếu DD khi:

  Albumin huyết thanh < 3,5 g/dl

2. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ ĂN CHO BỆNH NHÂN

1. Khi đa ra các chế độ ăn khác nhau phải đảm bảo sự cân đối, đầy đủ và toàn diện của nó, phù hợp với đặc tính biết trớc của bệnh, chú trọng những bệnh đặc biệt.

2. Xác định thời hạn của chế độ ăn không cân đối, không tòan diện và không đầy đủ

3. Qui định những nguyên tắc ăn uống ở bệnh nhân tiến hành liệu pháp đặc biệt (liệu pháp sinh hoá, liệu pháp vật lí...)

4. Đề ra các nguyên tắc phối hợp giữa các yếu tố dinh dỡng, điều trị với việc sử dụng kháng sinh và các phơng tiện khác của liệu pháp thuốc

5. Qui định chế độ ăn phải phù hợp với hoạt động của bệnh nhân, chú ý tới việc đề phòng sự hạn chế hoạt động sau này do ảnh hởng của ăn uống gây ra

6. Nguyên tắc lựa chọn thực phẩm

- Hạn chế hoặc loại trừ các thức ăn thô, các thực phẩm khó tiêu
- Thực phẩm xay nhỏ và nghiền nhừ
- Chế biến tốt nhất là phơng pháp hấp và nấu, hạn chế phơng pháp rán

MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĂN ĐIỀU TRỊ

CHẾ ĐỘ ĂN THÔNG THỜNG

- Chỉ định: Những bệnh nhân mắc các bệnh thông thờng, không cần kiêng cữ gì đặc biệt.
- Nguyên tắc: Nhu cầu và tỷ lệ các chất dinh dỡng gần với ngời bình thờng

Cơ cấu khẩu phần	Giới hạn mức ăn trung bình	
	Tối thiểu	Tối đa
Tổng năng lợng (Kcal/ngày)	2000	2200
% NL từ Protein	12	15
% NL từ Lipid	15	25
% NL từ Glucid	55	75
Chất xơ dạng polysaccharid	16 g/ngày	24 g /ngày
Muối ăn		6-10 g /ngày
Rau các loại	200 g/ngày	300-500 g /ngày
Quả chín	100g/ngày	Tuỳ theo khả năng
Nớc uống	1500 ml	2500 ml

Chế độ ăn hạn chế năng lợng

1. Chế độ ăn trong bệnh đái tháo đờng

- Chỉ định : Cho đái đờng typ I và typ II
- Nguyên tắc

+ Đảm bảo đủ năng lợng để giữ cân nặng bình thờng. Đối với ngời béo cần giảm bớt năng lợng. Giảm NL từng bớc theo mức BMI

+ Không nên dùng đờng, mật, mứt, bánh kẹo, chocola

+ Đảm bảo tỷ lệ các thành phần sinh NL

+ Chất xơ: 20 - 40 g / ngày

+ Đủ vitamin, đặc biệt vitamin nhóm B để ngăn ngừa tạo thành xêton.

+ Muối < 6 g / ngày

- **Chỉ số đờng huyết**

Chỉ số đờng huyết phản ánh mức đáp ứng của Glucoza máu sau khi ăn thực phẩm nào đó so với bánh mì trắng làm chuẩn (100).

Chỉ số đờng huyết của một số thức ăn thông dụng:

Nhóm thực phẩm	Tên thực phẩm	Chỉ số đờng huyết	Nhóm thực phẩm	Tên thực phẩm	Chỉ số đờng huyết
Bánh mi	Bánh mi trắng	100	Rau củ	Khoai luộc	54
	Bánh mi toàn phần	99		Khoai sọ	58
Lơng thực	Gạo trắng	83		Cà rốt	49
	Lúa mạch	31		Củ từ	51
	Yến mạch	85		Khoai nớng	135
	Bột dong	95	đậu	Lạc	19
	Gạo giã rối	72		đậu tơng	18
Quả	Chuối	53		Hạtđậu	49
	Táo	53		đậu nớng	62
	Da hấu	72	Sữa	Sữa gầy	32
	Cam	66		Sữa chua	52
	Xoài	55		Kem	52
	Nho	43	Đường	đờng	86
	Mận	24			
	Anh đào	32			

2. Chế độ ăn điều trị béo phì

2.1. Nguyên tắc:

- Tạo đợc sự thiếu hụt năng lợng bằng cách năng lợng ăn vào ít hơn năng lợng tiêu hao từ 500-1000 Kcal sẽ dẫn tới giảm 10 % trọng lợng cơ thể trong vòng 6 tháng
- Hoặc giảm NL từng bớc theo mức BMI

+ BMI từ 25-29,9 thì NL đa vào 1500 kcal / ngày

+ BMI từ 30-34,9 thì NL đa vào 1200 kcal / ngày

+ BMI từ 35-39,9 thì NL đa vào 1000 kcal / ngày

+ BMI >= 40 thì NL đa vào 800 kcal / ngày

2. Chế độ ăn điều trị béo phì *(tiếp theo)*

- **2.2. Thành phần các chất dinh dỡng**

- Protid :15-25 %
- Lipid : 15 % , nên tăng các axit béo cha no một hoặc nhiều nối đôi
- Glucid : nên sử dụng G có nhiều chất xơ
- Đủ vitamin và muối khoáng
- Tăng cờng rau và quả chín 500g /ngày
- Muối nên < 6 g / ngày nếu có tăng HA thì dùng 2-4 g / ngày
- Không nên dùng đờng, mật, mứt, kẹo, bánh kẹo, chocola…

Chế độ ăn giảm Protein

Trong khẩu phần có dới 1g Pr/kg.

- Giảm ít: 0,8 - 0,9 g/kg.
  Trứng + sữa + thảo mộc.
- Giảm trung bình: 0,6 - 0,8g/kg.
  Ngũ cốc, khoai, rau qủa.
- Giảm nhiều: 0,4 - 0,5g/kg.
  Cơm + qủa + đờng (kempner).
- Bỏ hẳn protid: chế độ ăn Borat - Bull.
  Dầu 200 g + đờng 400g.

Chỉ định:

- Khi cơ thể không bài tiết đợc sản phẩtm chuyển hóa Pr : Viêm cầu thận cấp, suy thận mạn (số gam protein = số ure niệu trong 24 giờ x 3)

- Khi Pr trở thành chất độc : Hôn mê gan, hội chứng toan (trong đái đờng)

- Khi Pr không tiêu hóa đợc do rối loạn tiêu hóa : viêm đại tràng, rối loan tiêu hoá, suy tuy tang

Chế độ ăn hạn chế lipid

Đặc điểm của lipid:

- Sinh năng lợng : 1g sinh 9,3 kcal
- Có khả năng dự trữ ở các tổ chức cơ thể khi ăn thừa li pid
- Gây co túi mật

Chỉ định:

- Bệnh béo phì
- Bệnh túi mật: Viêm túi mật, sỏi mật do cholesterol lắng đọng
- Xơ mỡ động mạch : Do mảng lipid lắng ở nội mạc mạch máu (cholesterol + este của cholesterol và phospholipid)

*Tắc mật : Nên ăn trứng , kem hoặc dầu thực vật giúp tống mật ra ngoài

Chế độ ăn hạn chế muối

Bình thờng trong CĐĂ có 10-15 g muối Nacl gồm:

- 40 % muối dùng để nấu nớng
- 40 % có trong các TPchế biến bằng muối
- 20 % có sẵn trong các thức ăn thiên nhiên

Có hai mức hạn chế :

Tơng đối: 1,25 - 2,5 g Nacl (0,5-1 g Na)

Tuyệt đối: 0,50 - 1,0 g Nacl (0,1-0,3 g Na)

Chỉ định:

- Suỷ tim.
- Huyết áp cao.
- Bệnh thận.
- Xơ gan.
- Phụ nữ có thai 3 - 6 tuần lễ cuối.
- Bệnh hạn chế nớc.

1.Chế độ ăn hạn chế muối tơng đối (Nacl 1,25 - 2,5 gam)

- Cấm nấu các thức ăn bằng muối
- Không đợc dùng TĂ bằng muối (kể cả nớc mắm)
- Không đợc dùng cà muối, cá muối và thịt muối
- Đợc phép dùng : Các TĂ có rất ít muối nh thịt, cá n-ớc ngọt, gạo khoai, rau quả tơi và thức ăn bản chất có khá nhiều muối: trứng sữa, cua , nội tạng....

2. Chế độ ăn hạn chế muối tuyệt đối (Nacl 0,5 - 1 gam)

- Cấm dùng các TĂ nh chế độ trên, cấm cả thức ăn thiên nhiên có sẵn muối nh : Sữa , trứng, cua.....

Chế độ ăn chỉ có cơm qủa đờng. Không có thịt, cá và sữa bò

CĐĂ hạn chế sợi, xơ và chất kích thích

- Chỉ định:Trong bệnh loét dạ dày tá tràng, viêm ruột

- Các TP nên dùng
  - Sữa, bơ
  - Khoai nghiền bỏ xơ, rau non mềm
  - Trứng
  - Quả thật chín, nớc quảl

- Mức độ hạn chế
  - Hạn chế chặt chẽ : chỉ có sữa bột
  - Hạn chế trung bình: thêm khoai nghiền và trứng
  - Hạn chế ít: thêm thịt mềm thái nhỏ và rau nghiền kĩ

Bệnh nhân nặng thì dùng chế độ hạn chế chặt chẽ, khi đã đỡ có thể dùng chế độ ăn hạn chế vừa hoặc ít

CHẾ ĐỘ ĂN TOAN VÀ KIỀM

CHẾ ĐỘ ĂN HẠN CHẾ PURIN

- Chỉ định: Trong bệnh Gout và bệnh Calci thận

- Nên ăn các TP có chứa < 50 g purin/ngày (sữa không béo, bánh mì, ngũ cốc, gạo, khoai tây..)

Nuôi dỡng bệnh nhân đặc biệt

- Bệnh nhân bỏng
- BN nuôi dỡng bằng ống thông
- Bệnh nhân sau mổ dạ dầy

Nuôi dỡng bệnh nhân đặc biệt

1. CHẾ ĐỘ ĂN CHO BỆNH NHÂN BỎNG

Chỉ định:

- Bỏng mức độ nhẹ: Hỗ trợ dinh dỡng bằng đờng tiêu hoá 4 giờ đầu sau nhập viện

- Bỏng mức độ trung bình đến nặng: DD bằng đờng miệng nên áp dụng càng sớm càng tốt, thờng 24-48 giờ sau hồi sức. Có tác giả khuyên nên đặt ống thông dạ dày để nuôi dỡng

2. Nuôi dỡng bằng ống thông (chế độ ăn hoàn toàn lỏng)

Chỉ định

- Uốn ván
- Viêm màng não
- Liệt họng vì bạch hầu
- Sau phẫu thuật quan trọng
- Hôn mê

- Cách truyền

  Dùng ống thông dài khoảng 1 m, đờng kính 1,2 - 1,5 mm. Bôi Glyxerin hoặc Vaselin rồi cho ống thông vào mũi rất từ từ, khi tới họng thì bảo bệnh nhân nuốt đồng thời ấn ống thông xuống tận dạ dày

- Cách cho ăn

- Nhỏ giọt liên tục 60 giọt / 1 phút hoặc cho ăn 3 - 4 lần/1 ngày.
- Bơm dung dịch qua ống thông 300-400 ml/lần. Bơm 5-6/lần.
- Sau khi cho ăn cần bơm một ít nớc qua ống thông để rửa khỏi tắc ống.
- Cố định ống thông

- Thời gian và số lượng dùng.

- Cho ăn trong 7-15 ngày, có thể ăn lâu hơn nhng phải thay ống thông 1-2 lần / 1 tháng
- Số lợng : Tuỳ theo tình trạng bệnh lý và khả năng tiêu hóa, hấp thu của BN mà cho ăn từ 500 - 2000 kcal / ngày
- Chia làm nhiều giai đoạn: Cho ăn tăng dần (bắt đầu 500 Kcal và 30 g protein, sau đó mỗi ngày cho ăn thêm 250 - 500 calo cho đến khi đợc 2000 Kcal)
- Chế biến phải nhuyễn, số lợng ít, thành phần DD cao. Có thể dùng bột mộng khi chế biến

- Tai biến

- Đau bụng, đầy hơi, ỉa lỏng
- Hội chứng “Dumping” : Sau khi ăn xong bệnh nhân mệt, nhức đầu, toát mồ hôi run ở bắp cơ do thức ăn thoát khỏi dạ dày quá nhanh, hoặc thức ăn quá đặc hoặc dạ dày bị dãn
- Bệnh nhân nôn mửa

3. Chế độ ăn cho bệnh nhân sau mổ dạ dầy

- Chỉ định:

❖ Trong cắt bỏ hoặc nối thông dạ dày-ruột

❖ Phẫu thuật chỉnh hình môn vị, cát bán phần dạ dày

(Đọc SGK)

Nguyên tắc:

- Từ 3-5 ngày đầu ăn qua ống thông
- Sau 5-7 ngày bệnh nhân có thể dung nạp đợc thức ăn đặc
- Nhu cầu các chất dinh dỡng: protein 1,5-2g/kg/ngày và 35-40kcal/kg/ngày. Sử dụng một lợng chất xơ và Pectin trong rau và quả giúp giảm hội chứng Dumping. Chú ý bổ sung đủ sắt, B12 và a.folic
- Đờng chỉ dùng nếu có hạ đờng huyết.Tránh các thức ăn ngọt hoặc nớc ngọt có ga. Nên tập cho bệnh nhân dùng sữa lợng nhỏ tăng dần, nếu BN không dung nạp do thiếu men Lactose có thể dùng sản phẩm MCT (Medium-Chain-Triglicerid)
- Chia thành bữa nhỏ 6 lần /ngày

Hớng dẫn chế độ ăn bệnh viện Bộ Y Tế - 2006

Nguyên tắc xây dựng CĐĂ BV

- Đối với người lớn: Bao gồm 12 CĐĂ

- Đối với trẻ em: Bao gồm 10 CĐĂ, chia theo nhóm tuổi (6 nhóm tuổi).

- Từng CĐĂ trong BV có các kí hiệu riêng

Hớng dẫn chế dộ ăn bệnh viện Bộ Y Tế - 2006

STT	Chế độ ăn trong bệnh viện	Ký hiệu
IV	Chế độ ăn cho bệnh Gút (người lớn)	GU
1	Bệnh gút đơn thuần	GU01-X
2	Bệnh gút có kết hợp với suy thận mạn độ 1, 2	GU02-X
3	Bệnh gút có kết hợp với suy thận mạn độ 3, 4	GU03-X

Những yếu tố quyết định thành công của dinh dỡng điều trị

1. Theo dõi sự tuân thủ chế độ ăn của bệnh nhân
2. Hiểu biết về thói quen ăn uống của ngời bệnh
3. Quan sát hành vi ăn uống của ngời bệnh
4. Chăm sóc những trờng hợp đặc biệt
5. Xây dựng thực đơn
6. Giáo dục bệnh nhân